PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



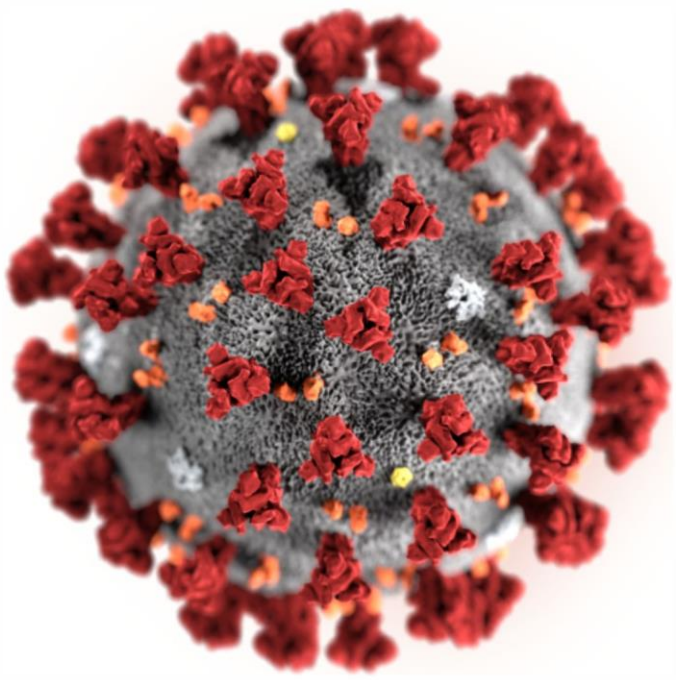
Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento do Novo Coronavírus - SARS nCoV2

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO DESIDÉRIO
JUSTIÇA SOCIAL E PROGRESSO

SESASD
SECRETARIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento do Novo Coronavírus - SARS nCoV2



São Desidério-Bahia
Abril, 2020

Prefeito Municipal
José Carlos de Carvalho

Secretário Municipal de Saúde
José Neves Barbosa

Diretoria Assistência Hospitalar
Adrianno José de Oliveira Almeida do Nascimento
Leidiane Gomes de Araújo

Diretoria Assistência Farmacêutica
Diolino Honorio Pereira
Mayara Monteiro dos Santos Pinheiro

Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental
Luzeni Alves dos Santos

Vigilância Epidemiológica
Roberta Dalmaso
Maria Joaquina

Diretora Departamento Atenção Primaria
Tatiane Rodrigues Santos
Ana Carla Moreno Pereira

Diretoria do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência-SAMU
Cleidimar Chagas Pereira

Diretoria de Saúde Bucal
Thiago Silva Vieira

Assessoria de Comunicação Social
Adinete Batista dos Santos

Comissão Técnica de Elaboração:

José Carlos de Carvalho
José Neves Barbosa
Adrianno José de Oliveira Almeida do Nascimento
Leidiane Gomes de Araújo
Diolino Honorio Pereira
Mayara Monteiro dos Santos Pinheiro
Luzeni Alves dos Santos
Roberta Dalmaso
Maria Joaquina
Tatiane Rodrigues Santos
Ana Carla Moreno Pereira
Cleidimar Chagas Pereira
Thiago Silva Vieira
Adinete Batista dos Santos

Comissão Técnica de Revisão:

José Carlos de Carvalho
José Neves Barbosa
Adrianno José de Oliveira Almeida do Nascimento
Leidiane Gomes de Araújo
Diolino Honorio Pereira
Mayara Monteiro dos Santos Pinheiro
Luzeni Alves dos Santos
Roberta Dalmaso
Maria Joaquina
Tatiane Rodrigues Santos
Ana Carla Moreno Pereira

SUMÁRIO

Apresentação.....6
Objetivos.....8
Objetivo Geral.....8
Objetivos Específicos.....8
Ações.....9
Ações de Vigilância em Saúde -..... 9
Vigilância Epidemiológica -.....9
Vigilância Sanitária -.....9
Ações de Atenção Primária.....11
Ações da Atenção Especializada Hospitalar.....13
Suporte Laboratórial.....15
Assistência Farmacêutica.....16
Comunicação e Informação em Saúde.....17
Gestão.....18
Serviço de Saúde Disponível.....18
Serviço Móvel de Urgência (SAMU 192).....18
Rede de Referência Hospitalar.....19
Serviço de Referência para Realização do Exame Diagnóstico.....20
Critérios de Definição de Casos para Notificação de COVID-19.....20
Notificação.....21
Referências.....22
Anexo 1.....23
Anexo 2.....24
Anexo 3 25
Anexo 4 50

APRESENTAÇÃO

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em razão da disseminação do Coronavírus, após reunião com especialistas. Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011. Diante da Emergência de Saúde Pública do Novo Coronavírus (SARS nCoV2) e com base nas informações e recomendações disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Municipal de Saúde de São Desidério Bahia apresenta o Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento do vírus SARS nCoV2. O presente documento foi elaborado pelas diversas aréas técnicas que compõe a Secretaria Municipal de Saude e departamento de Gestão. Tendo como finalidade instrumentalizar os Profissionais de Saúde e Sociedade Civil quanto as ações adequadas e oportunas, para redução dos danos ocasionados pelo vírus na população. Considerando as constantes atualizações disponibilizadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e MS (Ministério da Saúde), o referido Plano está sujeito a ajustes decorrentes da sua utilização prática e das mudanças observadas no cenário epidemiológico.

As medidas e acões apresentadas por meio de eixos enfatizam as medidas a serem adotadas de acordo aos niveis de resposta apresentados a saber:

- **Eixo 01: Vigilância Sanitária e Epidemiológica:** contempla as ações específicas de Vigilância Sanitária e Epidemiológica para controle da Infecção Humana pelo Coronavirús;
- **Eixo 02: Atenção Primária/Saúde Bucal:** contempla as ações Primárias de controle ao Novo Coronavirús;
- **Eixo 03: Atenção Especializada Hospitalar:** contempla ações de Manejo Clinico aos pacientes acometidos por COVID-19 e articulação redes de referências;

- **Eixo 04: Suporte Laboratorial:** contempla ações de Diagnóstico e Fluxo de Amostras para Laboratório de referência;
- **Eixo 05: Assistência Farmacêutica:** contempla ações para adoção de Protocolos Terapêuticos e Educação em Saúde:
- **Eixo 06: Comunicação e Informação em Saúde**: contemplam as ações informativas a população a cerca do Novo Coronavirús;
- **Eixo 07: Gestão**: contempla as ações de articulação das diversas aréas Técnicas da Administratração Pública para controle do Novo Coronavirús;
- **Eixo 08: Serviços Complementares:** contempla as ações desenvolvidas pelos Serviços Complementares (SAMU);

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo Geral

Adoção de Ações para enfrentamento de forma rápida e coordenada a pandemia do Novo Coronavírus (SARS nCoV2) no município de São Desidério-Bahia.

1.2 Objetivos Específicos

- Organizar o fluxo de ações de prevenção e controle do Coronavírus;
- Traçar estratégias para redução da transmissão da doença, por meio do monitoramento e controle dos pacientes já detectados;
- Garantir a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma oportuna;
- Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de decisão;
- Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede municipal de saúde;
- Ampliar e qualificar o acesso da população à ações e serviços da Atenção Especializada Hospitalar conforme cenário epidemiológico.
- Garantir acesso aos serviços de saúde de forma equanime, integral e qualificada por meio de processos regulatórios.
- Desenvolver estratégias e mecanismos de cooperação entre as esferas de gestão.
- Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que serão implementadas;
- Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos;

2. AÇÕES

2.1 Eixo 1 – Vigilância em Saúde:

2.1.1-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA:

- Promover e ou realizar capacitação para profissionais de saúde na rede publica sobre Covid19 juntamente com Manejo Clinico com base nos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde;
- Elaborar e implantar os fluxos de atendimento no âmbito intra-hospitalar e na Atenção Primária de pacientes suspeitos e confirmados da Covid 19;
- Fortalecer os serviços de saúde para detecção, notificação, investigação e monitoramento de casos suspeitos da COVID19;
- Coletar amostras de secreção respiratória para diagnostico laboratorial mediante aos casos suspeitos seguindo critérios de coleta conforme orientações do LACEN-BA, e realização de teste rápido;
- Fornecer dados de casos suspeitos, confirmados, monitorados, descartados e curados para ASCOM (Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São Desidério), para atualização dos boletins informativos diários para publicação nos meios de comunicação oficiais;
- Monitorar quarentena juntamente com Atenção Básica e orientar os indivíduos identificados que vierem de outros Municípios e ou Estados;
- Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle da infecção humana da doença pela COVID-19.
- Realizar alimentação dos sistemas de notificações da COVID-19.

2.1.2- VIGILÂNCIA SANITÁRIA:

- Orientar todos os responsáveis por estabelecimentos do município (religiosos, educacionais, comerciais, industriais e outros), com o

objetivo de informar sobre medidas de prevenção para o Novo Coronavírus, previstas em norma municipal, estadual e federal;

- Reforçar a realização de procedimentos de higienização dos estabelecimentos de saúde e dos demais estabelecimentos públicos e privados;
- Disponibilizar material informativo para viajantes sobre prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus e outros vírus respiratórios;
- Realizar ações de vigilância dos viajantes e trabalhadores, para reforça-los das medidas preventivas para não transmissão da Covid-19;
- Implantar barreira sanitária nas entradas da sede do município e no distrito de roda velha, como forma de prevenir a transmissão e propagação do coronavirus;
- Fiscalizar as empresas de interesse da saúde, cobrar o plano de contigência para enfrentamento do novo coronavírus e acompanhar se as ações estão sendo desenvolvidas;
- Orientar e fiscalizar o cumprimento dos cuidados pós-morte causada pela COVID-19 junto às famílias e à funerária de acordo com as notas técnicas do Ministério da Saúde;
- Fiscalizar e exigir o cumprimento do isolamento domiciliar por todos aqueles que se enquadrarem nos critérios;

2.1.3- Vigilância em Saúde do Trabalhador

- Exigir o plano de contingência frente à COVID 19 das empresas que atuam no município, em especial dos produtores agrícolas, e sua efetiva aplicação;
- Criar equipe volante de saúde do trabalhador para desenvolvimento das ações de orientação e fiscalização;
- Fiscalizar a oferta adequada de EPIs aos profissionais que atuam no município, para assegurar a saúde do trabalhador, para servidores públicos e empregados de empresas privadas;

- Realizar capacitação quanto à proteção individual e coletiva dos profissionais de limpeza pública para evitar contaminação por COVID e outras patologias;

2.2 Eixo 2 – Atenção Primária:

- Capacitar os profissionais da saúde com esclarecimentos a respeito da COVID-19.
- Publicar informações atualizadas por meio de ambiente virtual junto à coordenação de Saúde Bucal.
- Disponibilizar álcool gel na sala de espera para todos os pacientes.
- Fornecer equipamentos de proteção individual adequados para profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).
- Organizar das salas de espera para atendimento com distância mínima de um metro entre pacientes.
- Realizar triagem anterior ao atendimento no consultório, para verificar possíveis sintomas da COVID-19 que, quando detectados, devem ser prontamente encaminhados para atendimento médico com EPI adequado.
- Suspender temporariamente o agendamento para procedimentos eletivos e consultas.
- Restringir atendimentos odontológicos a regime de urgência e emergência
- Restringir atendimentos médicos apenas para urgência e emergência e programas essenciais.
- Garantir a renovação de receitas de medicação de uso contínuo, para que não seja descontinuado nenhum tipo de tratamento para doenças crônicas.
- Preservar o atendimento do pré-natal, de todas as gestantes assintomáticas com intervalo de horários para diminuir contato entre ela.

- Notificar e monitorar durante 14 dias ou mais, quando necessário, os casos suspeitos e confirmados da COVID-19 bem como os seus comunicantes.
- Encaminhar os casos moderados e graves de COVID-19 ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, acompanhado da ficha de referência e notificação.
- Priorizar o atendimento nos casos que apresentem sinais e sintomas de Síndrome Gripal em sala restrita bem como ofertar mascara cirúrgica.
- Disponibilizar EPIs adequados aos profissionais que atuam na linha de frente seguindo os critérios de uso determinados pela OMS;
- Orientar os profissionais quanto a técnica de lavagem das mãos, limpeza e desinfecção dos objetos e superfícies que são tocados com frequência.
- Discutir sinais e sintomas, transmissão, manejo clínico, formas de prevenção, estratégias para o enfrentamento, dentre outros assuntos relacionados à COVID-19, em todas as equipes de saúde da atenção primária;
- Enviar para VIEP informação por meio da planilha informativa juntamente com envio das notificações de casos suspeitos em tempo oportuno;
- Realizar busca ativa juntamente com os ACS de casos suspeitos de síndrome gripal na área de abrangência de cada ESF;
- Reconhecer precocemente os casos suspeitos de COVID-19.
- Reservar sala de atendimento para casos suspeitos de COVID-19 em todas as Unidades de Saúde.
- Realizar no domicílio a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza para os idosos e garantir a imunização de todos os profissionais de Saúde.
- Disponibilizar teleatendimento médico para consultas e orientações sobre a COVID-19, como forma de evitar que a pessoa se desloque até a unidade de saúde.
- Disponibilizar teleatendimento de psicologia para portadores confirmados de COVID-19 com transtornos emocionais relacionadas a esta patologia.

- Disponibilizar, em parceria com a assistência social e vigilância em saúde, equipe para organização das filas bancárias, lotéricas e comércios, nas quais será realizada higienização com álcool a 70% ou lavagem das mãos, distribuição de máscaras e orientação para distanciamento entre as pessoas nas filas.
- Realizar lenvantamento do quantitativo de pessoas do grupo de risco nas áreas de abrangência de todas as Unidades de Saúde.

2.3 Eixo 3 – Atenção Especializada Hospitalar

- Desenvolver capacitações para os profissionais de saúde em conjunto com o Departamento de Vigilância Epidemiológica e Sanitária quanto ao acolhimento, cuidado, medidas de isolamento, limpeza e desinfecção de superfícies, higienização das mãos na atenção hospitalar;
- Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos para a infecção humana pela COVID-19;
- Prover a unidade de insumos e equipamentos médico-hospitalares para atendimento de pacientes suspeitos e confirmados para infecção humana pela COVID-19;
- Implantar fluxogramas/protocolos de acolhimento, triagem e espera por atendimento para usuários com sintomas respiratórios;
- Disponibilizar leitos para casos suspeitos/ confirmados que necessitarem de internamento hospitalar respeitando o fluxograma de referência instituído pela regional;
- Apoiar na elaboração de fluxos intrahospitalares para o itinerário do paciente e desenvolvimento das atividades pelos profissionais na avaliação e monitoramento dos casos suspeitos/confirmados;
- Pomover a articulação da rede de urgência, emergência e laboratorial (públicos e privados) para coleta e transporte oportunos e adequados das amostras para diagnóstico laboratorial;

- Estabelecer e apoiar o uso de Equipamentos de Proteção Individual para os profissionais de acordo com o protocolo de manejo clínico para a infecção humana pela COVID-19, conforme recomendação da ANVISA;
- Suspender temporariamente os atendimentos ambulatoriais, exames laboratóriais e cirurgias eletivas, visando evitar aglomerações e reduzir o risco de transmissibilidade do vírus;
- Implantar lavatórios em pontos de maior circulação de pessoas no HMNSA;
- Implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19;

Promover manejo clínico ao paciente suspeito/acometido pela COVID-19 utilizando critérios de classificação de risco baseados no Protocolo de Tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), da seguinte forma:

Gravidade	Quadro Clínico
VERDE	Indivíduo com suspeita ou confirmação, estável, sem sinais de piora do estado clínico*.
AMARELO	Indivíduo com suspeita ou confirmação, com sinais de gravidade (dispneia; desconforto respiratório; saturação de O2 menor que 95%; ou exacerbação de doença preexistente) e fatores de risco**.
VERMELHO	Indivíduo com suspeita ou confirmação, com sinais de gravidade (choque; disfunção dos órgãos vitais; insuficiência respiratória; ou instabilidade hemodinâmica).

***Sinais de piora do estado clínico:** persistência ou agravamento da febre por mais de três dias; miosite comprovada por CPK (≥ 2 a 3 vezes); alteração do sensório; desidratação e, em crianças, exacerbação dos sintomas gastrointestinais.

****Fatores de risco:** população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso; gestantes; puérperas (até duas semanas após o parto); crianças <5 anos; adultos

(≥60 anos); pneumopatias (incluindo asma); cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica); doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme); distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus); transtornos neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção congênita, lesões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou doenças neuromusculares); imunossupressão (medicamentos, neoplasias, HIV/aids); nefropatias e hepatopatias; obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal – IMC ≥ 40 em adultos); pacientes com tuberculose de todas as formas.

Orientações Gerais

- Os pacientes acometidos pela COVID-19 classificados como casos leves devem ser acolhidos e orientados, inclusive quanto à importância do isolamento domiciliar, conforme orientações vigentes;
- Os pacientes acometidos pela COVID-19 devem ser acolhidos, classificados e estabilizados, nos casos classificados como “Amarelo”, deve-se realizar o encaminhamento às Unidades de Referência, conforme quadro clínico;
- Os pacientes acometidos pela COVID-19 classificados como “Vermelho” devem ser encaminhados às Unidades de Referência, via regulação;
- As Unidades de Referência devem tratar os casos “Amarelo” e encaminhar os casos agravados as Unidade de Referência de maior complexidade;
- As Unidades de Referência devem tratar os casos graves e avaliar o encaminhamento dos casos com melhora clínica (“Amarelo”) retornando à unidade de origem, na perspectiva do cuidado progressivo;

2.4-Eixo 4-Suporte Laboratórial:

- Organizar fluxos para diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a infecção humana pela COVID-19 ;

- Seguir fluxos de laboratórios de referência (LACEN-BA/UFOB-BARREIRAS) para envio de amostras para infecção humana pela COVID-19 e outros vírus respiratórios;
- Monitorar os fluxos de transporte para o envio de amostras para os laboratórios de referência;
- Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para a COVID-19 e outros vírus respiratórios;
- Comunicar a Vigilância Epidemiológica os resultados laboratoriais para adoção de medidas de prevenção e controle;
- Realizar coleta e entrega dos exames em domicílio em caso de Síndrome Gripal classificada como leve pela equipe de coleta da Vigilância Epidemiológica;
- Seguir os critérios de coleta de exames: do terceiro ao sétimo dia coleta de swab naso-orofaríngeo e do 8° ao 14° dia coleta de muco-salivar ou teste rápido.

2.5 – Eixo 5 – Assistência Farmacêutica:

- Realizar levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção humana pela COVID-19.
- Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes.
- Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço farmacêutico.
- Garantir medicamento específico para os casos de SG (Sindrome Gripal) e SRAG (Síndrome Respiratória Agúda Grave) que compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir.
- Monitorar o estoque de medicamentos e insumos farmacêuticos em âmbito Municipal.
- Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação a demanda.
- Assegurar o estoque de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para profissionais de saúde.

- Realizar educação permanente e a orientar quanto ao uso adequado dos EPI’s.
- Implantação de protocolos farmacêuticos conforme nota informativa do Ministério da Saúde N° 5/2020.
- Entrega em domicílio de medicamentos de uso contínuo a pacientes cadastrados na Secretaria de Saúde;

2.6 – Eixo 6 - Comunicação e Informação em Saúde

- Articular estratégias de comunicação e divulgação no enfrentamento da COVID-19 através das midias sociais (Facebook, Instagram e grupos de watshapp) bem como boletins informativos diariamente contendo os dados da situação epidemiologica do município.
- Publicação de matérias acerca das ações desenvolvidas pela gestão, no que tange ao enfrentamento da pandemia;
- Produção e publicação de cards nas mídias sociais com orientações aos munícipes sobre as medidas preventivas
- Publicação dos Decretos e Portarias em relação à COVID-19 em Diário Oficial do municipio;
- Divulgação através de Spots diários em programação de rádio, sobre as recomendações do Ministério da Saúde.
- Divulgação em Comunicação Volante (carro de som) diariamente sobre as recomendações e medidas preventivas no enfrentamento a COVID-19 na sede, nos distritos e povoados do municipio.
- Criação de um Link específico para publicação das ações, decretos, portarias, boletins e despesas relacionadas à COVID-19 no site oficial do município www.saodesiderio.ba.gov.br.

2.7 Eixo 7- Gestão:

- Implantar no município a Comissão técnica de Enfrentanto a Covid-19;
- Promover ações integradas entre as diversas áres técnicas da Secretaria Municipal de Saúde e outros órgãos envolvidos na prevenção e controle da COVID-19.
- Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário epidemiológico atualizado da COVID-19.
- Garantir a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, manuais, guias, notas técnicas, entre outros).
  Garantir o cumprimento das ações emergênciais no enfrentamento da COVID-19.
- Elaboração de Decretos, Portarias e demais atos normativos após avaliação/aprovação da Comissão Técnica e posteriormente a publicação em Diário Oficial do municipio.
- Garantir além dos EPI's todos os recursos necessários ao enfrentamento da COVID-19;

3. SERVIÇOS DE SAÚDE DISPONÍVEIS

3.1 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)

É um serviço territorializado que possibilita a cada vítima um atendimento no menor tempo possível, com envios de equipe qualificada para o atendimento de vitimas, conforme a gravidade do caso. Podemos chamá-lo de **atendimento pré-hospitalar móvel primário** quando o pedido de socorro for oriundo de um cidadão ou de **atendimento pré-hospitalar móvel secundário** quando a solicitação partir de um serviço de saúde, no qual o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento necessário à estabilização do quadro de urgência apresentado, mas necessite ser conduzido a outro serviço de maior complexidade para a continuidade do tratamento, conforme grade de referência pactuada.

O SAMU regional Barreiras/Ibotirama é composto por 22 bases descentralizadas e uma central de regulação de urgência localizada na cidade de Barreiras, prestando assistência a população da região Oeste da Bahia.

No que diz respeito ao atendimento presencial do paciente com suspeita de infecção humana pelo Novo Coronavirus (COVID-19) devem ser utilizadas as seguintes medidas:

- Realização de capacitação da equipe para manejo clínico do paciente em caso suspeito ou confirmado da COVID-19;
- Disponibilizar e orientar quanto ao uso dos EPIs preconizados pela ANVISA de acordo ao tipo de atendimento;
- Realizar orientação para acompanhante/familiares quanto a higienização das mãos;
- Adaptação da viatura para uma melhor higienização após atendimento de casos suspeitos ou confirmados da COVID-19.
- Adoção de medidas a serem tomadas durante o atendimento pré-hospitalar e transporte inter-hospitalar de pacientes, tais como:

  A – ofertar máscaras cirúrgicas para o paciente e o acompanhante em todos os atendimentos pré-hospitalar;

  B – Garantir a ventilação interna do veiculo durante o transporte;

  C – Realizar limpeza e desinfecção de todas as superficies internas após a realização de atendimento, utilizando álcool a 70%, Hipoclorito de sódio ou outro desinfectante indicado para este fim.

3.2 Rede de Referência Hospitalar

As pessoas consideradas suspeitas são aquelas que se enquadram nos critérios clínicos e epidemiológicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde e suas atualizações. Estas serão atendidas nos diferentes pontos de atenção da rede assistencial e podem ter como primeiro acesso, os seguintes equipamentos de saúde: (i) Unidade de Saúde da Família e Unidade Básica de Saúde (no âmbito da atenção primária); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e Portas de Urgência e Emergência Hospitalar (no âmbito da atenção especializada).

3.6 Serviço de Referência para Realização do Exame Diagnóstico

O diagnóstico laboratorial está centralizado no UFOB/LACEN-BA, devido à complexidade da metodologia. Quanto a coleta de Swab para diagnóstico laboratorial, o município esta seguindo o subitem V da Nota Tecnica COE Saúde Nº 54 de 08 de Abril de 2020.

Os casos que atendem aos criterios de coleta de Swab, se classificado como leve sera coletado no domicilio do paciente por uma equipe que foi devidamente capacitada, já os casos que exigirem internamento hospitalar, serão coletados na unidade hospitalar.

Até o presente momento os transportes das amostras estão sendo enviadas juntamente com a cópia da ficha de Notificação para o Nucleo Regional de Saúde, onde posteriormente sera encaminhado para a UFOB em Barreiras, respeitando os prazos estabelecidos.

Os kits de teste rapido para Covid 19 atenderão os criterios da Nota Informativa Nº 2/2020-SAP\MS.

4. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CASOS PARA NOTIFICAÇÃO DE COVID-19

Todo individuo que for classificado dentro dos criterios do Ministerio da Saúde, deverão ser notificados por meio da Ficha Especifica de Investigação de SG Suspeito de Doença pelo Coronavirus 2019-COVID-19 (B34. 2). O quadro de classificação de caso suspeito compreende o indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza;

Em crianças: considera-se tambem obstrução nasal, na ausência de outro diagnostico especifico e nos idosos: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar tambem criterios especificos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

Os casos classificados como grave, deverá ser preenchida a Ficha Especifica de Notificação de Síndrome Respiratoria Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO).

4.4.5 Notificação

A notificação de caso suspeito pela COVID-19 devem ser realizadas imediatamente nas Unidades de Saúde do município e encaminhadas no mesmo dia à Vigilância Epidemiológica que ficará responsável pela digitação no sistema seguindo as seguintes modalidades:

- Classificados como Leves: registrar os dados no sistema e-SUSVE através do link de acesso https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/ .
- Classificados como Graves: (Hospitais, ou em casos de SRAG que evoluirão para óbitos): registrar os dados no sistema SIVEP-Gripe através do link de acesso ttps://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/.

6. REFERÊNCIAS

- Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde – https://www.saude.gov.br/saude- dea-z/coronavirus
- Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Centro de Operações de Emergência em Saúde. Boletim Epidemiológico N° 01. Brasília, 2020.
- Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico N° 04. Brasília, 2020.
- Word Health Organization https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus- 2019

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária - http://portal.anvisa.gov.br/coronaviruse Agência Nacional de Vigilância Sanitária – http://portal.anvisa.gov.br/documents
- Nota Técnica Conjunta DIVEP/LACEN/SESAB Nº 01de 27 de janeiro de 2020. Governo do Estado da Bahia. Lei Estadual Nº 13.706/2017.
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica GVIMS/GGTESANVISA Nº4/2020.

ANEXO I

FLUXO DE ATENDIMENTO DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS

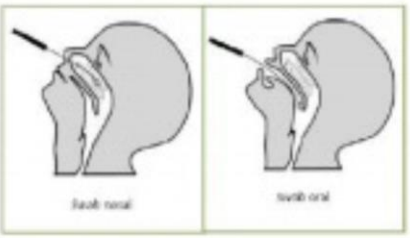
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

A coleta da amostra de secreção respiratória é feita preferencialmente por swab combinado (secreção de naso e orofaringe: coleta com 3swabs de Rayon acondicionados juntos em 01 frasco com meio de transporte viral – caldo triptose fosfato).



Swab de Rayon

Caldo Triptose Fosfato (meio de transporte viral)



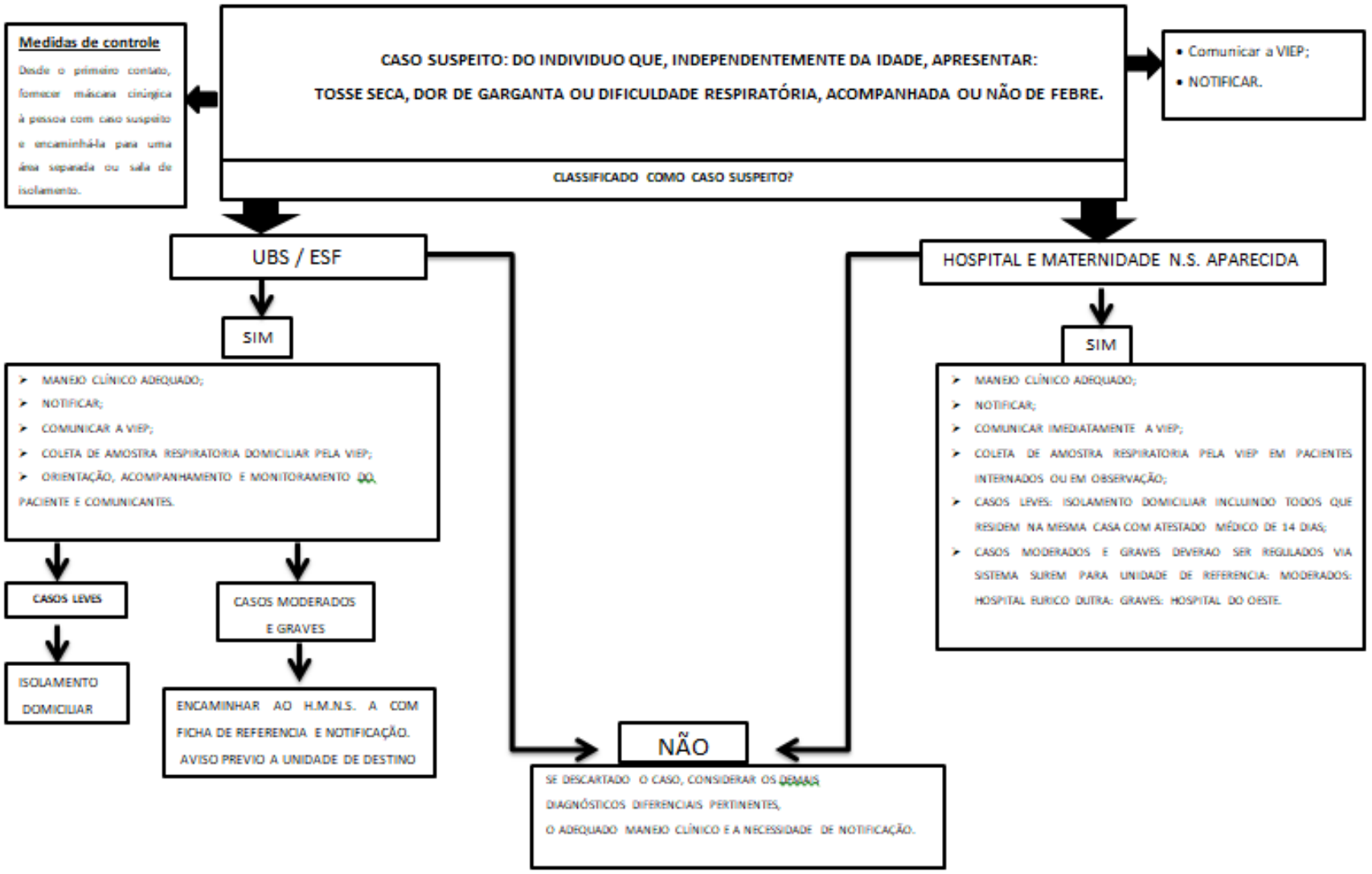
OBS: <u>Todas as amostras deverão ser corretamente identificadas com nome completo do paciente, data e local da coleta</u>.

A amostra coletada deverá ser encaminhada ao **LACEN/MS** para a pesquisa de vírus Influenza e outros vírus respiratórios. A requisição deverá ser feita no GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial, sistema eletrônico do **LACEN/MS**). Incluir pesquisa de COVID-19 no campo ***"Observações"*** do GAL, assim como a cronologia das viagens e dos sintomas.

A caixa de térmica com a amostra deve manter a temperatura entre 4°C e 8°C, ser identificada e a requisição do GAL e FICHA DE NOTIFICAÇÃO impressa afixada na parte externa da caixa.

ANEXO II

FLUXOGRAMA NOVO CORONAVÍRUS DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO



ANEXO III

Protocolo Interno
Equipamentos de Proteção Individual- Segurança da Equipe no Atendimento de Pacientes com COVID-19

1. **OBJETIVOS:**

Descrever o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de forma segura, para profissionais da saúde e demais pacientes.

2. **JUSTIFICATIVAS:**

Fornecer orientações do uso correto de equipamentos de proteção individual para segurança da equipe assistencial e demais pacientes, no atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados COVI-19.

3. **DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:**

Isolamento:
• Preferencialmente em quarto privativo, com porta fechada e bem ventilado;
• Para transporte de pacientes não intubados: estes devem usar máscara cirúrgica.

Para todos os casos suspeitos ou confirmados:
• Óculos de Proteção ou Protetor Facial;
• Máscara Cirúrgica, mas preferencialmente máscara de proteção respiratória (N95, PFF2 ou similar);
• Gorro;
• Macacão Impermeável;
• Luvas de Procedimento.

Para procedimentos geradores de aerossóis (Intubação Orotraqueal, Aspiração Traqueal, Ressuscitação Cardio Pulmonar, Coleta de amostras Nasotraqueais e Broncoscopia):
• Todos os acima;
• Obrigatório: Máscara de Proteção Respiratória (N95, PFF2 ou similar).

Capacitação para lavagem das mãos, Paramentação e Desparamentação: (Segurança do paciente / CCIH realizará treinamentos no local de trabalho).
Observações:
- Em função do risco de contaminação da equipe, os seguintes procedimentos devem ser realizados apenas quando necessários, conforme descrição nos roteiros das diversas etapas do atendimento do paciente e com máximo rigor em relação à utilização dos EPIs: Ventilação com Máscara e Máscara Laríngea.
- Aguardar por novas evidências e recomendações em relação à utilização de VNI e cateter nasal de alto fluxo;
- **Recomendamos a não utilização de Macronebulização de O2 e Administração de Medicações através de nebulização;**
- Na intubação orotraqueal, utilizar bloqueador neuromuscular e não ventilar o paciente antes de insuflar o cuff;

Figura 1: Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus (COVID19) (OMS, 28.01.2020).

Casos suspeitos ou confirmados e acompanhantes	• usar máscara cirúrgica • usar lenços de papel (tosse, espirros, secreção nasal) • higienizar as mãos frequentemente com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica
Equipe médica, de enfermagem, fisioterapia, ou outros profissionais que prestarem assistência direta ao paciente com suspeita ou confirmado para COVID19	• higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica • usar óculos de proteção induvidual; • usar máscara cirúrgica; • usar avental impermeável (descartável); • usar luvas de procedimento; Observação: os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, PFF2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo: intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais.
Demais profissionais de saúde, de apoio, laboratório, radiologia, cardiologia, que precisarem entrar no quarto no paciente com suspeita ou confirmado para COVID19	• higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica • usar óculos de proteção individual • usar máscara cirúrgica • usar avental impermeável (caso toquem no paciente ou ambiente do paciente) • usar luvas de procedimento

Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA, janeiro de 2020

*A definição de transmissão local é a confirmação laboratorial do COVID19 entre pessoas com vínculo epidemiológico comprovado. Entre familiares próximos ou profissionais de saúde de forma limitada não é considerado transmissão local.(Nota técnica 001/2020 – DIVE/LACEN/SES/SC

Tipo do Documento	PROTOCOLO INTERNO	PROTOCOLO Nº 02
Título do Documento	PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE VENTILAÇÃO MECÂNICA EM PACIENTES COM COVID-19	Emissão: 14/05/2020

Protocolo Assistencial de Ventilação Mecânica em pacientes com COVID-19

1. OBJETIVOS:

Descrever o Protocolo Assistencial de Pacientes suspeitos ou confirmados COVID-19 com necessidade de Intubação Orotraqueal e Ventilação Mecânica.

2. JUSTIFICATIVAS:

Fornecer orientações de procedimentos necessários para manejo de pacientes em Ventilação Mecânica com infecção por COVID-19 confirmada ou suspeita.

3. DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO:

PÓS IOT OU TRANSFERÊNCIA:

▪ Verificar posicionamento do TOT (Ausculta Pulmonar) e fixação do tubo orotraqueal; ▪ Aferir pressão do cuff entre 20-30 mmHg ou até vedação completa (cessação do escape);
▪ Checar filtro HMEF ou HEPA/HME;
▪ Checar colocação sistema de aspiração fechado (TrachCare);
▪ Posicionar suporte dos circuitos mais elevado, posição “flecha”, a fim de evitar e retardar condensações que levem a necessidade de troca;
▪ Titular parâmetros ventilatórios iniciais de acordo com fluxograma institucional :

PARÂMETROS INICIAIS DA VM:

-Modo: PCV;
-Volume Corrente: 4 a 6 ml/kg;
-PEEP: 10;
-FR: 16 a 20 irpm;
-Driving Pressure (Pressão): 15 cmH2O;
-Pressão de Pico: <30 cmH2O;
-Relação I: E: 1:2 a 1:3;
-FIO2: 60% a 100% (sempre utilizar o menor valor necessário para manter SatO2);
-SatO2: 92% a 95%;

***Em caso de PCR reajustar Parâmetros para:**

- Modo volume controlado (VCV);
-FR = 12 irpm;
- FiO2 = 100%;
- PEEP (Pressão Positiva Expiratória Final) = 0cmH2O;
-VC = 8mL/kg;

AMBIENTE:
▪ Quarto de Isolamento ou Isolamento Coletivo.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INIDIVIDUAL:
▪ Óculos de Proteção ou Protetor Facial;
▪ Máscara de Proteção Respiratória (N95, PFF2 ou similar);
▪ Gorro;
▪ Macacão Impermeável;
▪ Luvas de Procedimento (02 Pares);

MONITORIZAÇÃO:
▪ ECG;
▪ PNI(Pressão Arterial Não-Invasiva**)** OU PAI(Pressão Arterial Invasiva**)** (se vasopressor);
▪ Oximetria de Pulso;
▪ Temperatura;
▪ Capnógrafo;

OBSERVAÇÃO:

▪ Posição PRONA nos casos não responsivos, conforme Check-List Posição Prona (16 a 21 hs).
Check-List:
-Proteger os Olhos;
-Realizar Higiene de Vias Aéreas;
-Assegurar Posicionamento TOT;
-Certificar posicionamento e fixação de Cateteres e demais Dispositivos;
-Interromper Dieta;
-Preparar apoios para Cabeça, Tórax, Pelve e outros;
-Proteger Proeminências Ósseas com rodilhas;

IMPORTANTE:

-Não realizar ventilação boca-a-boca, mesmo com dispositivo portátil;
- Não ventilar com Máscara e Ambú (Evitar Aerossóis).

Tipo do Documento	PROTOCOLO INTERNO	PROTOCOLO Nº 03
Título do Documento	REANIMAÇÃO EMERGÊNCIA ADULTO COVID-19	Emissão: 14/05/2020

Reanimação Emergência Adulto COVID-19

1. OBJETIVO:

Descrever o protocolo de atendimento de paciente suspeito ou confirmado COVID-19 em caso de necessidade de reanimação cardiopulmonar.

2. JUSTIFICATIVAS:

A reanimação cardiopulmonar segue as recomendações de acordo com a sua causa e de acordo com o ritmo cardíaco. A principal particularidade do atendimento à PCR em paciente com doença confirmada ou suspeita pelo novo coronavírus é minimizar o risco de contaminação da equipe. Dessa maneira, esse protocolo foca somente nos aspectos que visam minimizar a contaminação. Os demais aspectos devem ser seguidos conforme os protocolos recomendados internacionalmente pela American Heart Association.

3. PROTOCOLO PARA REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR: PARTICULARIDADES EM PACIENTES COM COVID-19 SUSPEITO OU CONFIRMADO:

RECOMENDAÇÃO 1 – IDENTIFICAR PACIENTES EM RISCO DE DETERIOÇÃO CLÍNICA

• Os pacientes com maior risco de deterioração clínica devem ser identificados e corretamente monitorados para que não se atrase as medidas de suporte necessárias:

- **Sinais de desconforto respiratório:** Sat O2 < 95% em ar ambiente, taquipneia e esforço respiratório;
- **Fatores de risco para mal prognóstico:** idade > 60 anos, cardiopatias, pneumopatias,

RECOMENDAÇÃO 2 – ESTABELECER DIRETIVAS INDIVIDUALIZADAS PARA A REANIMAÇÃO

• Identificar pacientes cuja causa da PCR tenha chance nula de ser revertida ou que não terão benefício da reanimação cardiopulmonar:

- Hipoxemia Refratária;
- Choque Séptico Refratário;
- Comprometimento prévio importante da funcionalidade;
- Desejo prévio de não reanimação;

• Individualizar o processo de tomada de decisão para diretivas de reanimação junto ao paciente ou aos seus familiares;

• **Registrar claramente no prontuário qualquer diretiva de não reanimação.**

RECOMENDAÇÃO 3 – ENVOLVER O MENOR NÚMERO DE PROFISSIONAIS POSSÍVEL

Pelo risco de contaminação, o menor número possível de profissionais deve ser envolvido: 1 Médico, 1 Enfermeiro e 2 Técnicos de Enfermagem

RECOMENDAÇÃO 4 – VESTIR TODOS OS EPIs ANTES DE INICIAR A REANIMAÇÃO

• Nenhum profissional que não estiver com todos os EPIs está autorizado a iniciar manobras de reanimação cardiopulmonar;

• Kits com os EPIs recomendados devem estar disponíveis nos carrinhos de reanimacão.

PONTOS-CHAVE PARA PREVENIR A CONTAMINAÇÃO DURANTE A REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR EM PACIENTE COM COVID-19 CONFIRMADO OU SUSPEITO:

A reanimação cardiopulmonar propriamente dita segue as recomendações de acordo com a sua causa e de acordo com o ritmo cardíaco. A principal particularidade do atendimento à PCR em paciente com doença confirmada ou suspeitada pelo novo coronavírus é minimizar o risco de contaminação da equipe. Dessa maneira, esse protocolo foca somente nos aspectos que visam minimizar a contaminação. Os demais aspectos devem ser seguidos conforme os protocolos recomendados internacionalmente pela American Heart Association.

1. **Identificar Pacientes com maior risco de evoluírem para PCR**

O relato de profissionais que já lidaram no atendimento de pacientes hospitalizados por COVID-19 é de que muitos pacientes que inicialmente tinham poucos sinais de instabilidade deterioram rapidamente o seu estado clínico. Dessa maneira, é essencial a identificação de pacientes sob o risco de deterioração para que as medidas de suporte não sejam tomadas tardiamente, minimizando o risco de o paciente apresentar PCR durante o curso de sua doença ou durante procedimentos como a intubação oro-traqueal.

2. Identificação de pacientes NÃO candidatos à reanimação cardiopulmonar:

A reanimação cardiopulmonar envolve um número relativamente maior de profissionais do que outros procedimentos e tem grande potencial de contaminação, principalmente pela produção de aerossóis pelas compressões cardíacas. Dessa maneira, deve-se selecionar pacientes com chances razoáveis de se beneficiarem. A identificação de pacientes que não sejam candidatos às manobras de reanimação, como pacientes com comprometimento prévio importante de sua funcionalidade, candidatos a cuidados paliativos no fim da vida, ou aqueles que já tenham diretivas de não reanimação, pode evitar a exposição desnecessária da equipe. Pacientes que estejam evoluindo com hipoxemia refratária (hipoxemia grave mantida apesar da otimização da FiO2 e da PEEP) ou choque refratário (hipoperfusão tecidual apesar do aumento progressivo da dose de drogas vasoativas) têm chance nula de reverter uma PCR. A reanimação desses pacientes tem enorme potencial de expor a equipe desnecessariamente ao risco de contaminação e sempre que possível deve ser evitada.

3. Equipe com o menor número de profissionais:

O menor número de profissionais deve ser envolvido na reanimação cardiopulmonar, a fim de minimizar o número de profissionais expostos ao risco de contaminação. Um médico (via aérea e desfibrilador), um enfermeiro (infusão de drogas) e dois técnicos de enfermagem (revezamento nas compressões torácicas) é a equipe mínima.

4. Uso de todos os EPIs recomendados

Os profissionais envolvidos no atendimento ao paciente em PCR devem vestir todos os EPIs recomendados para procedimentos que gerem aerossol. Não está permitido o início da reanimação por profissional sem todos os seguintes EPIs: gorro, máscara N95, óculos de proteção e/ou protetor facial , máscara cirúrgica por cima da N95, macacão impermeável, luvas e pró-pés. Para minimizar o atraso até o inicio das compressões, 4 kits com os EPIs devem estar disponíveis em cada carro de reanimação. Considerando que os profissionais já estarão com suas máscaras N95, os kits devem conter gorro, óculos de proteção e mascara cirúrgica para por cima da N95, avental, luvas e pró-pés.

5. Hands-only nos pacientes não intubados

Em pacientes não intubados que evoluam para PCR e que a reanimação esteja indicada, essa deve ser iniciada somente com as compressões torácicas. A intubação oro-traqueal deve ser realizada em momento oportuno e não deve retardar a desfibrilação se o ritmo for chocável. **Ventilação boca-a-boca, mesmo com dispositivo portátil de proteção, fica proibida pois acarreta retirada de EPI e contato direto com secreção contaminada. Ventilação com Dispósitivo Bolsa Valva-Máscara (ambú) deve ser evitado, pois produz aerossóis.**

6. Ventilações nos Pacientes Intubados:

Para minimizar a formação de aerossóis, pacientes já intubados não devem ser desconectados do ventilador durante a reanimação cardio-pulmonar. De maneira similar, após uma intubação feita no cenário de reanimação cardio-pulmonar, o paciente deve ser conectado imediatamente ao ventilador. Se disponível no aparelho, deve-se utilizar o dispositivo “PCR” para fornecer as ventilações.

Tipo do Documento	PROTOCOLO INTERNO	PROTOCOLO Nº 04
Título do Documento	CHECK LIST TRIAGEM EMERGÊNCIA ADULTO COVID-19	Emissão: 14/05/2020

Check List Triagem Emergência Adulto COVID-19

1. OBJETIVO:

Descrever os critérios para utilização na triagem de pacientes com sintomas respiratórios na emergência COVID-19;

2. JUSTIFICATIVA:

Padronizar o processo de avaliação inicial do paciente com sintomas respiratórios na vigência do crescimento de casos de COVID-19, na emergência específica respiratória. Visa otimizar fluxo, liberação de casos leves, registrar dados importantes para a notificação e seguimento dos casos e encaminhar para atendimento médico os pacientes com achados de risco para evolução com complicações respiratórias.

3. DESCRIÇÃO DO CHECK LIST:

Fornecer máscara cirúrgica a todos com caso suspeito (que relate ou manifeste sintomas respiratórios) e encaminhá-los para o atendimento em Área Restrita.

***São considerados pacientes de Grupo de Risco para este protocolo:**

- Idade acima de 60 anos;
- Pneumopatias Graves ou Descompensadas (Asma Moderada/Grave, DPOC);
- Doença Renal Crônica em Estagio Avançado;
- DM (Diabetes Mellitus);
- HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica);
- Cardiopatias Graves ou Descompensadas (Insuficiência Cardíaca, Cardiopatia Isquêmica);
- Transplantados;
- Imunossuprimidos: neutropenia, neoplasias doenças onco-hematológicas, asplenia (retirada de baço por qualquer causa), quimioterapia nos últimos 30 dias, uso de corticoide sistêmico – prednisona 40mg/d por mais de 15 dias, doenças autoimunes (doenças reumatológicas), imunodeficiência congênita;
- HIV com CD4 < 350;
-Gestação de Alto Risco;
- Gestantes ou puérperas até 45 dias (consideradas de risco em virtude de outras síndromes respiratórias).

***Sintomas Clínicos necessários para avaliação de gravidade e suspeita de COVID-19:**

APRESENTAÇÕES LEVES:

- Febre por mais de 24h;
- Fadiga/Astenia;
- Tosse, Seca ou Purulenta;
- Mialgia;
- Dor de Garganta;
- Cefaleia;
- Congestão Nasal / Coriza;
- Sintomas Gastrointestinais – diarreia, náuseas, vômitos

APRESENTAÇÕES GRAVES:

- Febre por mais de 24h;
- Dispneia;
- Dificuldade para respirar;
- Exacerbação de Doença Respiratória preexistente;
- Irritabilidade / Confusão mental;
- Batimentos de asas de nariz;
- Cianose;
- Tiragens Intercostais;
- FR > 30 resp/min;
- FC > 125 bpm/min;
- SatO2 < 95% em Ar Ambiente;
- Pacientes considerados grupos de risco.

Critérios de Isolamento Domiciliar:

• Pacientes com sintomas respiratórios leves.
• Deve ser fornecido atestado para 14 dias para o individuo sintomático e para os que residem no mesmo local + monitoramento de todos os envolvidos, em caso de indivíduos sintomáticos solicitar exames:
Do **2º ao 7º** dia solicitar coleta de Swab nasoorofaringeo para COVID-19.
Do **8º ao 14º** dia solicitar coleta de escarro/saliva, teste rápido para COVID-19 ou sorologia para COVID-19, esse a partir do 10º dia de sintoma.
• A Unidade irá Notificar os casos em Formulário Especifico atendendo os critérios da Nota Técnica COE Saúde Nº 54 DE 08 de Abril de 2020 e registro em Planilha Pória ;

- Contactar a Vigilância Epidemiológica para realização de Visita Domiciliar ao paciente e coleta de SWAB para COVID-19 atendendo aos critérios
- Fornecer orientações ao Paciente/Familiar sobre o Isolamento Domiciliar conforme Portaria Nº 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020;

Encaminhamento para Atendimento Hospitalar:

• Presença de pelo menos um sintoma grave (considerar neste caso a febre aferida e não somente a febre relatada);
• Pacientes considerados Grupos de Risco com Sintomas Respiratórios, mesmo que leves.

Critérios para Notificação:

Deverão ser notificados todos os pacientes que apresentarem os sintomas de Síndrome Gripal como:

- **Quadro Respiratório agudo caracterizado por febre ou sensação febril, acompanhada de tosse e/ou dor de garganta e/ou coriza e/ou dificuldade respiratória.**

Critério de Alta Hospitalar:

- Paciente afebril há pelo menos 3 dias (72h) + sintomas respiratórios em curva de melhora + exames laboratoriais em curva de melhora.

- É importante salientar que a maioria dos pacientes que evoluem mal, apresentam quadro dispneia 5 a 8 dias após o início dos sintomas. Sendo assim, os pacientes devem ser orientados a retornar ao hospital em caso de piora após a alta.
- Fornecer ao paciente orientações quanto à quarentena.

Tipo do Documento	PROTOCOLO INTERNO	PROTOCOLO Nº 05
Título do Documento	PROTOCOLO DE TRATAMENTO COVID-19	Emissão: 14/05/2020

Protocolo de Tratamento na COVID-19

Casos leves:

- **Sintomáticos – evitar AINES**
- **Azitomicina 500 mg 1x ao dia por 5 dias.**
- **Hidroxicloroquina 400 mg de comp. 2x ao dia no 1° dia, do 2° ao 5° dia apenas 01 comprimido ao dia.**
- **Isolamento domiciliar.**

Obs: Em caso de internação iniciar anticoagulante profilático

Casos moderadas:

- Internação e transferência para unidade de referência (HMED) o quanto antes.
- **Azitromicina 500 mg** 1x ao dia por 5 dias.
- **Hidroxicloroquina 400 mg** 01 cp de 12/12 hs no 1° dia, do 2° ao 5° dia 01 cp ao dia.
- **Oseltamivir 75 mg** 01 comp de 12/12 horas por 05 dias. **(solicitar teste rápido para influenza, suspender se negativo) (PRIORIZAR GRUP**
-
- **O DE RISCO)**
- **Ivermectina 6 mg** dose única (profilaxia para Strongyloides)

Tabela de Dose Única	
15 a 24 kg	½ comprimido
25 a 35 kg	01 comprimido
36 a 50 kg	1 ½ comprimido
51 a 65 kg	02 comprimidos
66 a 79 kg	02 ½ comprimidos
≥ 80 kg	0,2 mg/kg

- **Clexane 40 mg SC 1x/dia**
  Ou
  Heparina não fracionada 5.000 UI SC de 12/12 horas

- **Ceftriaxona 1g** EV de 12/12 horas (Avaliar necessidade de Cefepima)

Continuação casos moderadas:

- **Corticóides** (Iniciar apenas após o 5º dia de sintoma, marcador inflamatório elevado e/ou acometimento pulmonar mesmo que seja mínimo).

1º dia **Metilprednisolona ------ 250 mg** _____1x ao dia.
SF 0,9%------ 200 ml **EV (Correr em 1 hora)**
Idoso ------ 125 mg

Do 2° ao 3° dia **Metilprednisolona ----- 80 mg**_____1x ao dia.
SF 0,9%------ 200 ml **EV (Correr em 1 hora)**

OU

1º dia **Dexametasona --------- 20 mg** _____1x ao dia.
Sf 0,9 % ---------- 100 ml **EV (Correr em 30 min)**

Do 2° ao 4° dia **Dexametasona --------- 10 mg** _____1x ao dia.
Sf 0,9 % ---------- 100 ml **EV (Correr em 30 min)**

Obs: Repetir Rx pulmonar de 1 a 2 dias, em caso de piora ou pequena melhora,
prolongar uso até o 5º dia.

Casos graves:

- Todas as condutas acima
- Intubação orotraqueal obedecendo protocolo abaixo.
- Transporte para unidade de referência via (SAMU-USA), devido necessidade de ventilador mecânico.

Tipo do Documento	PROTOCOLO INTERNO	PROTOCOLO Nº 06
Título do Documento	INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL	Emissão: 14/05/2020

Protocolo de Intubação orotraqueal na COVID-19

1. OBJETIVO:

Padronizar o procedimento de realização da Intubação Oro-traqueal em pacientes com suspeita ou confirmados de COVID-19 no ambiente Hospitalar.

2. SEQUÊNCIA RÁPIDA DE INTUBAÇÃO EM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19

ETAPA 1 – PREPARAÇÃO (Duração = minutos)

1. Médico mais experiente;
2. Equipe mínima (3 membros);
3. Vestir todos os EPI's;
4. Testar e preparar o tubo oro-traqueal para a intubação com circuito fechado.
• Retirar o êmbolo da seringa de 20 ml.
• Conectar o êmbolo no tubo vedando o mesmo.
• Clampear o tubo com pinça Kelly curva.
   - DE PREFERENCIA NÃO USAR FIO-GUIA. (Em caso de necessidade furar o embolo que veda o tubo e ao retirar o fio guia manter o embolo vedando o tubo, clampar o tubo com a pinça após retirada do fio-guia.
5. Testar o laringoscópio;
6. Ofertar O^2 por Unidade Ventilatória Baraka.
7. Testar fonte de O2 e vácuo;
8. Preparar o ventilador – filtro na válvula exalatória;
9. Posicionar o paciente: Snif Position;
10. Preparar as drogas para procedimento:
• Lidocaína 2%, ou Fentanil 50mcg/ml; **Pacientes Hemodinamicamente instáveis, Bradicardicos e Hipotensos evitar Fentanil**.
• Cetamina 50mg/ml ou Midazolam 15mg/3ml ou Etomidato 2 mg/ml **Pacientes Hemodinamicamente instáveis, Bradicardicos e Hipotensos evitar Midazolan.**
• Succinilcolina 100mg;
11. Preparar soluções para sedação contínua:
• Midazolam 20ml em 230mL de SF 0,9%;
• Fentanil 20mL em 210mL de SF 0,9%;
Preparar solução de noradrenalina
Preparar material para punção venosa profunda.

ETAPA 2 – PRÉ-OXIGENAÇÃO (Duração = minutos)

1. Aumentar o fluxo de O^2 pela Unidade Ventilatória Baraka.
2. Ofertar O2 pela Unidade Ventilatória Baraka até a máxima saturação do paciente:
• Não vedar a máscara – deixar pequena abertura para o paciente exalar.

ETAPA 3 – PRÉ-MEDICAÇÃO (Duração = segundos)

1. Infundir um analgésico potente para inibir reflexos da via aérea alta.
• Lidocaína 2% ou Fentanil 50mcg/ml, (**Doses na tabela em anexo)**

ETAPA 4 – INDUÇÃO RÁPIDA COM BLOQUEIO (Duração = segundos)

1. Infundir de forma rápida Cetamina 50mg/ml ou Midazolan 15mg/3ml ou Etomidato 2 mg/ml. **Pacientes Hemodinamicamente instáveis, Bradicardicos e Hipotensos evitar Midazolam. (Doses na tabela em anexo)**

2. Infundir "na carona", de forma rápida, Succinilcolina. **(Doses na tabela em anexo)**

Importante: administrar o pré-indutor lidocaína 3 minutos antes do indutor e administrar o bloqueador neuromuscular na sequência, sem demora, após indutor.

Importante: é essencial a administração de bloqueador neuromuscular para fins de paralisar o paciente, facilitar intubação e evitar contaminação da equipe por aerossóis gerados durante procedimento;

MEDICAMENTOS NA SEQUÊNCIA RÁPIDA DE INTUBAÇÃO

PESO	LIDOCAÍNA 2%	CETAMINA	SUCCINILCOLINA
- 45 kg	3,4 ml	1,8 ml	4,5 ml
- 50 kg	3,8 ml	2,0 ml	5,0 ml
- 55 kg	4,1 ml	2,2 ml	5,5 ml
- 60 kg	4,5 ml	2,4 ml	6,0 ml
- 65 kg	4,9 ml	2,6 ml	6,5 ml
- 70 kg	5,3 ml	2,8 ml	7,0 ml
- 75 kg	5,6 ml	3,0 ml	7,5 ml
- 80 kg	6,0 ml	3,2 ml	8,0 ml
- 85 kg	6,4 ml	3,4 ml	8,5 ml
- 90 kg	6,8 ml	3,6 ml	9,0 ml
- 95 kg	7,1 ml	3,8 ml	9,5 ml
- 100 kg	7,5 ml	4,0 ml	10,0 ml

Succinilcolina 100mg - **Diluir em 10ml de água destilada.**

ATENÇÃO: APRESENTAÇÃO DISPONIVEL NA UNIDADE DE 500mg

OPÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA INTUBAÇÃO

PESO	FENTANIL 50mcg/ml	MIDAZOLAM 15mg/ml	ETOMIDATO 2mg/ml
- 45 kg	0,9 ML	1,8 ML	8 ML
- 50 kg	1 ML	2 ML	9 ML
- 55 kg	1,1 ML	2,2 ML	9,5 ML
- 60 kg	1,2 ML	2,4 ML	10 ML
- 65 kg	1,3 ML	2,6 ML	10,4 ML
- 70 kg	1,4 ML	3 ML	10,5 ML
- 75 kg	1,5 ML	4 ML	11 ML
- 80 kg	1,6 ML	4 ML	12 ML
- 85 kg	1,7 ML	4 ML	13 ML
- 90 kg	1,8 ML	4 ML	13,5 ML
- 95 kg	1,9 ML	4 ML	14 ML
- 100 kg	2 ML	4 ML	15 ML

3. JUSTIFICATIVA:

Fornecer orientações de processos e técnicas necessárias para segurança do paciente e proteção da equipe contra o contágio durante procedimentos das vias aéreas em pacientes com infecção por COVID-19 confirmada ou suspeita;

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:

1. Indicações:

ETAPA 5 – LARINGOSCOPIA (Duração = Segundos)

Iniciar a laringoscopia imediatamente após o fim das fasciculações causadas pela succinil-colina, ou se não houver fasciculações, assim que o paciente parar os movimentos respiratórios.

ETAPA 6 – INTUBAÇÃO COM CONFIRMAÇÃO

(Duração = segundos)

• Inserir o tubo Orotraqueal vedado e clampeado com pinça Kelly curva ou reta angulada para cima;
• Inflar o cuff mantendo o êmbolo e a pinça.
• Retirar o êmbolo e conectar ao respirador.
• Retirar a pinça.
• Verificar posição correta do tubo com auscuta pulmonar.
• Fixar o tubo.
• Iniciar imediatamente solução padrão para sedação continua.

Midazolam 02 ampolas em 230 mL de SF 0,9%---- 10 microgotas/min ou 10 ml/hora na Bomba de infusão contínua
Fentanil 04 ampolas em 210 mL de SF 0,9% ---- 10 microgotas/min ou 10 ml/hora na Bomba de infusão contínua

PONTOS-CHAVE PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL

1. Profissional de maior experiência com intubação na equipe: A realização da intubação orotraqueal por profissional experiente aumenta a chance de sucesso na primeira tentativa, reduzindo a necessidade de ventilação por unidade ventilatória Baraka e minimizando a produção de aerossóis.
2. A equipe mínima: Só o número essencial de profissionais deve participar da intubação, para que o menor número possível de profissionais fique exposto ao risco de contaminação. Recomenda-se o médico mais experiente, um enfermeiro e um técnico de enfermagem (ou fisioterapeuta se disponível na unidade)
3. Vestir todos os EPIs recomendados: Todos os profissionais envolvidos devem utilizar os EPI's recomendados: gorro, máscara N95, face shield (ou óculos de proteção e máscara cirúrgica por cima da N95), macacão impermeável, luvas e pró-pés.
4. Posicionar o paciente adequadamente – sniff position Um posicionamento adequado, com a flexão cervical (articulação C7-T1) e extensão da cabeça (articulação atlanto-occipital), a sniff position, permite a melhor visualização da laringe, minimizando a necessidade e se aproximar excessivamente da cavidade oral do

paciente, diminuindo o risco de contato com secreções ou aerossóis. Apesar da posição de hiperextensão cervical facilitar a ventilação por unidade ventilatória Baraka, também desloca anteriormente a glote. Isso causa dificuldade para visualizar a laringe. A reação do profissional é se aproximar da cavidade oral para tentar visualizar a laringe, podendo aumentar o risco de contaminação. Em pacientes obesos, sugere-se a colocação de coxim em região torácica alta (para posicionamento em rampa), e posteriormente o posicionamento “sniff”.
5. Cuidar com o fluxo de oxigênio: O fluxo de alimentação de oxigênio para a unidade ventilatória Baraka e seu reservatório deve ser mínimo para manter o reservatório cheio. O fluxo excessivo pode gerar aerossóis.
6. Não realizar ventilação com máscara e ambú: A ventilação com máscara gera a produção de aerossóis a partir das secreções da via respiratória alta e aumenta o risco de infecção. Além disso, pode distender o estômago e aumentar o risco de broncoaspiração. A ventilação deve ser feita somente quando não se tiver sucesso na laringoscopia/intubação e o paciente apresentar dessaturação.
7. Bloqueio neuro-muscular: O uso de um bloqueador neuro-muscular (succinil-colina ou rocuronio) propicia o máximo relaxamento muscular do paciente e previne que o mesmo tenha reflexo de tosse ou sequer exale, reduzindo o risco de eliminação de secreções e aerossóis durante a laringoscopia e intubação.
8. Inserção imediata do sistema de aspiração fechada e do filtro: A inserção imediata do sistema de aspiração fechada e do filtro entre o tubo orotraqueal e o dispositivo usado para ventilação, pode minimizar a liberação de aerossóis e secreções, além de evitar a necessidade de novas desconexões do sistema.
9. Conectar o tubo orotraqueal diretamente ao ventilador mecânico: A conexão do tubo oro-traqueal (com o filtro e sistema de aspiração fechada) diretamente com o ventilador permite que todas as ventilações ocorram em um sistema fechado, minimizando a formação de aerossóis que pode acontecer quando se usa o ambú nas ventilações iniciais. Além do filtro entre o tubo orotraqueal e o sistema de traquéias do ventilador, deve-se colocar também um filtro na via exalatória do ventilador.
10. Iniciar a sedação contínua (e bloqueio neuro-muscular) de manutenção imediatamente após a intubação: O despertar do paciente logo após a intubação pode causar reflexo de tosse e produção de aerossóis. Imediatamente após a intubação, deve-se tentar minimizar o desconforto causado pelo tubo com a infusão de uma analgésico opióide potente e evitar que o paciente desperte logo após a intubação por meio da infusão contínua de sedativo. Para que o efeito desejado seja atingido é necessário um bolus inicial do sedativo na bomba e então a infusão contínua.
Observação: Técnicas para isolar a luz do tubo oro-traqueal têm sido amplamente disseminadas em vídeos nas redes sociais. Apesar de serem intuitivas para minimizar a contaminação do ambiente, essas técnicas tem pouco efeito se o paciente estiver com bloqueio neuro-muscular efetivo. Com o bloqueio nenhum fluxo de ar ou de secreção será gerado pelo paciente, dessa forma não haveria a necessidade de isolar a luz do tubo orotraqueal.

PONTOS-CHAVE PARA EVITAR A DESSATURAÇÃO DO PACIENTE

1. Profissional de maior experiência com intubação na equipe: A execução da intubação pelo profissional mais experiente com esse procedimento aumenta a chance de sucesso na primeira tentativa e por consequência, diminui o risco de dessaturação após a infusão do sedativo e do bloqueador neuro-muscular.
2. Pré-oxigenação Uma pré-oxigenação otimizada, preferencialmente encerrada somente após o paciente saturar 100%, minimiza o risco de dessaturação durante a laringoscopia e intubação. A elevação da cabeceira da cama, quando possível, pode aumentar o volume pulmonar residual e também minimizar o risco de dessaturação.
3. Indução anestésica com ketamina: O início do efeito da ketamina é muito rápido (15s após a sua infusão). Dessa maneira, propicia um intervalo de tempo menor entre

a infusão do sedativo e o início da laringoscopia, podendo minimizar o risco de dessaturação do paciente. Além disso, a ketamina tem efeito analgésico e não causa hipotensão arterial. Entretanto, outros sedativos podem ser utilizados se o médico responsável estiver mais familiarizado com algum deles. O midazolam é o mais disponível e utilizado pela grande maioria dos médicos emergencistas e intensivistas. Da mesma forma que para a ketamina, a infusão do bloqueador neuro-muscular deve também ser feita imediatamente após a infusão do midazolam.
4. Bloqueio neuro-muscular: O uso de um bloqueador neuromuscular (succinil-colina ou rocurônio) propicia o máximo relaxamento do paciente, o que aumenta a chance de sucesso na laringoscopia e na primeira tentativa de intubação, minimizando o risco de dessaturação. A sua infusão deve ser imediatamente após a infusão do sedativo. Não há necessidade de esperar o paciente dormir para infundir a bloqueador.

Quando utilizar O2 através da unidade ventilatória Baraka e qualquer um dos 4 sinais abaixo:

- Impossibilidade e manter SpO2 > 93%;
- FR > 30 m.r.m;
- Retenção CO2 (PaCO2 > 50 e / ou pH < 7.25);
- Sinais de desconforto respiratório (batimento de asa de nariz, tiragens intercostais ou de fúrcula, incoordenação abdominal);
- Instabilidade hemodinâmica progressiva com Noradrenalina > 0.4 ucg. kg.min;

Importante: Não retardar Intubação. Até novas evidências ou recomendações, evitar VNI, Cateter Nasal de Alto fluxo ou Macronebulização.

Pós Intubação Orotraqueal:

- Iniciar infusão contínua de Midazolam e Fentanil;
- Reajuste de parâmetros da VM conforme roteiro para VMI;
- Providenciar transporte para unidade de referência (HMED).

Tipo do Documento	PROTOCOLO INTERNO	PROTOCOLO Nº 07
Título do Documento	PROTOCOLO PARA TRANSPORTE INTER- HOSPITALAR NA COVID-19	Emissão: 14/05/2020

Protocolo para Transporte Inter Hospitalar na COVID-19

1. OBJETIVO:

Descrever o protocolo de Transporte de paciente Suspeito ou Confirmado COVID-19 .

2. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:

Para o atendimento Pré-Hospitalar móvel de urgência e transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2, deve-se:

- Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte (ar condicionado com exaustão, que garanta as trocas de ar ou manter as janelas abertas).

- **Toda a equipe envolvida no transporte do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2 deve utilizar EPIs como:**

- Oculos de Proteção;
-Protetor Facial;
-Máscara Cirúrgica ou trocar por Máscara N95/PFF2 ou Equivalente (caso seja realizado procedimento que possa gerar aerossóis)
- Avental Impermeável/Macacão Impermeável;
- Luvas de Procedimento;
- Toda a equipe deve receber capacitação e demonstrar capacidade para colocação, uso, retirada e descarte correto e seguro dos EPI.
- Sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2 será encaminhado
- Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte. A desinfecção deverá ser iniciada com a pulverização com hipoclorito de sódio, posteriormente realizar a desinfecção do mobiliário com álcool a 70%, indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos e realizar higiene das mãos com álcool a 70% e/ou água e sabonete líquido, após a realização da limpeza do veículo e retirada do EPI utilizado. Atenção: Recomenda-se que as portas e janelas da ambulância sejam mantidas abertas durante a limpeza interna do veículo.

Tipo do Documento	PROTOCOLO INTERNO	PROTOCOLO Nº 07
Título do Documento	ORIENTAÇÕES PÓS-ÓBITO DE PACIENTES COM INFECÇÃO SUSPEITA OU CONFIRMADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2)	Emissão: 14/05/2020

3. OBJETIVO:

Fornecer recomendações referentes ao manejo de corpos no contexto do novo coronavírus (COVID-19) e outras questões gerais acerca de óbitos.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Como o SARS-COV2 é transmitido por contato, gotículas e aerossóis, é fundamental que os profissionais sejam protegidos da exposição a sangue, secreções e fluidos corporais infectados, objetos ou outras superfícies ambientais contaminadas. Os princípios das precauções padrão de controle de infecção e precauções baseadas na transmissão devem continuar sendo aplicados no manuseio do corpo. Isso ocorre devido ao risco contínuo de transmissão infecciosa, embora o risco seja geralmente menor do que para pacientes ainda vivos.

5. MANEJO DE CORPOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO COVID- 19:

ATENÇÃO: RECOMENDA-SE QUE NÃO ENVIEM CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19 PARA O SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO (SVO)/ INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML). CASO A COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO NÃO TENHA SIDO REALIZADA EM VIDA, DEVE-SE PROCEDER A COLETA POST-MORTEM NO SERVIÇO (EM ATÉ 12 HORAS), POR MEIO DE SWAB NA CAVIDADE NASAL E DE OROFARINGE, PARA POSTERIOR INVESTIGAÇÃO. DIANTE DA NECESSIDADE DO ENVIO DE CORPOS AO SVO/INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML), DEVE SER REALIZADA A COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO GESTOR DO SERVIÇO PARA CERTIFICAÇÃO DE CAPACIDADE PARA O RECEBIMENTO.

a) Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar presentes no quarto ou área, os profissionais estritamente necessários (todos com EPI - equipamento de proteção individual);

b) Todos os profissionais que tiverem contato com o cadáver devem usar: touca, óculos de proteção (e protetor facial complementar), máscara cirúrgica, avental impermeável e luvas. Se for necessário realizar procedimentos que geram aerossol como extubação, usar N95, PFF2 ou equivalente;

c) Os tubos, drenos e cateteres devem ser removidos do corpo, tendo cuidado especial com a remoção de cateteres intravenosos, outros dispositivos cortantes e do tubo endotraqueal, tratando-os como resíduo infectante;

d) Descartar imediatamente os resíduos perfurocortantes em recipientes rígidos, à prova de perfuração e vazamento, e com o símbolo de resíduo infectante;

e) Tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter, bem como os orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar extravasamento de fluidos corporais. Se o cadáver for para o IML ou SVO (caso de investigação de causa de óbito) não está indicado o tamponamento dos orifícios naturais;

f) Realizar o Preenchimento da Declaração de Óbito (DO) emitida pelo Médico assistente que deverá realizar o preenchimento contendo as seguintes informações: Dados do paciente; Nome da Mãe; data e hora do óbito e causa; unidade onde ocorreu o óbito e assinatura do Médico/ Enfermeiro responsável pelo plantão.

g) Após a manipulação do corpo, remover os EPIs, descartá-los em lixo infectante;

h) Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão;

i) A unidade assistencial será responsável por transportar o corpo até o Necrotério do Hospital, devendo tomar todas as precauções de biossegurança durante o caminho, utilizando novos EPIs não contaminados: Luvas, Máscara Cirúrgica e Avental;
j) Após a guarda do corpo no Necrotério, retirar os EPIs e rouparias descartando imediatamente em local adequado e Higienizar as Mãos;
k) O serviço Funerário/Transporte deve ser informado de que o óbito se trata de vítima de COVID-19;
l) Os profissionais que atuam no transporte, guarda e alocação do corpo no caixão também devem adotar as medidas de precaução, aqui expostas, até o fechamento do caixão;
m) RECONHECIMENTO DO CORPO: Limitar a um único Familiar/Responsável para o reconhecimento do corpo NO MOMENTO DA ENTREGA À FUNERÁRIA. Lembrar que o cadáver está dentro da urna lacrada;
n) Sugere-se que não haja contato direto entre o Familiar/Responsável e o corpo, mantendo uma distância de 1,5 metros entre eles;
o) O corpo deve ser acomodado em urna a ser lacrada pela funerária antes da entrega aos Familiares/responsáveis;
p) Após lacrada, a urna não deverá ser aberta;

Tipo do Documento	PROTOCOLO INTERNO	PROTOCOLO Nº 08
Título do Documento	REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2)	Emissão: 14/05/2020

REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2)

1. OBJETIVO:

Padronizar o procedimento de realização Testes Rápidos para detecção do Novo Coronavìrus (SARS-COV-2) baseado Notas Técnicas Nº 5/2020-SAPS/MS e NOTA TÉCNICA Nº 11/2020-DESF/SAPS/MS.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

O teste rápido de COVID-19 é capaz de detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são produzidos pelas células de defesa pelo corpo humano contra o SARS-CoV-2 após o contato com vírus, por meio da coleta de uma gota de sangue. O resultado fica disponível no intervalo de 15 a 30 minutos após a realização. Os anticorpos podem ser detectados com melhor sensibilidade após o 7º dia de início dos sintomas, dependendo do método, podendo ser realizado entre o sétimo e o décimo dia. Existem limitações e variações de sensibilidade do teste conforme o tempo da doença.
O Ministério da Saúde por meio da NOTA TÉCNICA Nº 11/2020-DESF/SAPS/MS E NOTA TÉCNICA Nº 5/2020-SAPS/MS disponibiliza a realização de testes rápidos para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 aos serviços de saúde, recomendando a sua realização para população que apresentar quadro de Síndrome Gripal, se enquadrando em uma das seguintes categorias:
-Profissionais de Saúde e Segurança em Atividade: mínimo 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal E mínimo de 72 horas assintomático;
-Pessoas que resida no mesmo domicilio de um profissional de saúde ou segurança em atividade: mínimo 7 dias completos desde o inicio dos sintomas de Síndrome Gripal;
-Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos;
-Portadores de condições de saúde crônicas;
-População economicamente ativa;

A Síndrome Gripal caracteriza-se como um quadro Respiratório Agudo apresentando os sintomas de febre ou sensação febril, acompanhada de tosse e/ou dor de Garganta e/ou Coriza e/ou Dificuldade Respiratória.

A necessidade de atingir 72 horas de período assintomático, antes da realização do teste, se deve a evidência de redução importante da viremia após 72 horas do fim dos sintomas. Essa medida permite que o grau de transmissibilidade seja reduzido, mesmo na eventualidade de um resultado falso-negativo.

Caso o resultado do teste seja negativo, os profissionais de saúde e segurança ficam aptos a retornar imediatamente ao trabalho. Um resultado positivo determina afastamento de 14 dias, após o início dos sintomas. A mesma recomendação vale para o teste da pessoa com Síndrome Gripal que reside no mesmo domicílio de um

profissional de saúde ou segurança. Se o teste for positivo, o profissional deverá realizar 14 dias de isolamento domiciliar. Se for negativo, pode retornar ao trabalho.

Recomenda-se que os testes sejam disponibilizados aos pontos das Redes de Atenção à Saúde com maior contato com pacientes suspeitos de COVID-19, a saber:

- Hospitais
- Serviços de Urgência/Emergência;
- Unidades de Pronto Atendimento
- Unidades Básicas de Saúde

ANEXO

PRONTO ATENDIMENTO COVID-19
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

EU, _____ ___, RG nº _____ CPF nº _____ declaro que fui devidamente informado (a) pelo Médico (a), Dr. (a) que assina este termo, juntamente comigo, sobre os riscos que o tratamento com o fármaco HIDROXICLOROQUINA pode acarretar, além dos possíveis danos hepáticos, oftalmológicos, cardíacos, dermatológicos, imunológicos, nutricionais, psicológicos e psiquiátricos; e seus efeitos colaterais como diarreia, náusea, vômitos e cefaleia, sendo orientado também acerca das possíveis consequências da sua não realização; com o conhecimento da proposta terapêutica e suas bases cientificas atuais, estando de acordo com a duração do tratamento relatando caso sinta qualquer dos sintomas adversos e ciente do prejuízo NO caso descontinuação. Estou ciente de que HIDROXICLOROQUINA é apenas um tratamento em estudo tentativo para a Covid-19, ainda em estudos em que, portanto, os efeitos terapêuticos para essa doença não podem ser garantidos. Declaro que li as bulas oficiais, que estão no site da ANVISA dos medicamentos HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA em presença da equipe médica, e que tive todas minhas questões devidamente respondidas com respeito aos efeitos colaterais e aos riscos dessas medicações, e que concordo em receber o tratamento em estudo proposto, que é composto de HIDROXICLOROQUINA com possíveis associações de AZITROMICINA . E que estou plenamente consciente de que os efeitos terapêuticos desse tratamento em estudo ainda não podem ser assegurados por ninguém, já que se trata de um tratamento meramente em estudo adotado em regime de urgência cujo único objetivo é o de tentar aplacar a pandemia da Covid-19, e que estou plenamente consciente de que esse tratamento pode envolver todos os riscos e efeitos colaterais explicitados nas bulas desses medicamentos, além de outros riscos possíveis ainda não previstos nelas, dadas as interações medicamentosas. Estando ciente de todos esses riscos, declaro que considero que os eventuais benefícios advindos desse tratamento ainda em estudo (cuja eficácia e segurança, estou ciente, não foram ainda verificadas pela ANVISA), podem compensar os muitos riscos que posso vir a estar correndo ao decidir concordar em aceitar o convite e a oportunidade de receber voluntariamente o tratamento proposto. Declaro ainda, que fui perguntado e devidamente examinado acerca de meu quadro clinico e de outras medicações que estou tomando regulamente, pela equipe médica, de modo a afastar qualquer contraindicação da prescrição de HIDROXICLOROQUINA e AZITROMICINA para o meu organismo. Declaro que estou ciente de que não necessito aceitar este convite a participar do tratamento, e que posso interrompê-lo a qualquer momento se desejar.

Tratamento submetido com data de inicio ____/____/____ e previsão de termino ____/____/____ Paciente / Responsável Nome: _____

Grau de Parentesco ou Tipo de Relação _____

Assinatura: _____ RG. N° _____

São Desidério, Bahia, aos ____ do mês de _____ Horário: _____.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

EBSERH, Universidade Federal de Santa Catarina, Hospital Universitário, Professor Polydoro Ernani de São Thiago.

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020

NOTA TÉCNICA COE Saúde N° 54 de 08 de Abril de 2020

PORTARIA N° 356, de 11 de Março de 2020.

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATUAÇÃO NO PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID19)

MAIO DE 2020

SUMÁRIO

1 - MARCO LEGAL 51
2 - COMITÊ MUNICIPAL DE CRISE ..... **Erro! Indicador não definido.**
3 - APRESENTAÇÃO 52
4 - OBJETIVOS 52
4.1 - Objetivo Geral 52
4.2 - Objetivos Específicos 52
5 - PÚBLICO ALVO 53
6 - GESTÃO DO SUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 53
6.1 - Ações específicas no âmbito da GESTÃO DO SUAS 54
6.2 - Algumas ações são inerentes à área de Vigilância Socioassistencial, a saber: 55
7 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS: 55
7.1 - Ações específicas no âmbito dos Benefícios Eventuais: 55
8 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 56
8.1 - Ações Específicas no Setor do Cadastro Único e Programa Bolsa Família 56
9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 56
9.1 - Ações específicas no âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às famílias – PAIF: 57
9.2 - Ações específicas no âmbito do BPC/BPC na Escola: 57
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 58
10.1 - Ações específicas no âmbito da Média Complexidade - CREAS: 58
10.2 Ações específicas no âmbito da Alta Complexidade - ILPI: 58
11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 60

1 - MARCO LEGAL

Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social 63, de 30 de abril de 2020.

Portaria Ministério da Cidadania 369, de 29 de abril de 2020.

Portaria Ministério da Cidadania 368, de 29 de abril de 2020.

Portaria Ministério da Cidadania 58, de 15 de abril de 2020.

Portaria Conjunta Snas e SGFT 1, de 2 de abril de 2020

Portaria Ministério da Cidadania 54, de 1º de abril de 2020

Portaria Ministério da Cidadania 337, de 24 de março de 2020 – Medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública pela Assistência Social

Portaria Ministério da Cidadania 330, de 18 de março de 2020 – Cad Único Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Medida Provisória 926, de 20 março de 2020

Portaria Ministério da Cidadania 335, de 20 de março de 2020 – Cad Único Programa Bolsa Família (PBF)

Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) 54, de 1o de abril de 2020 – Aprovar recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas)

Portaria conjunta 1o, de 2 de abril de 2020 – Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) e Secretário de Gestão de Fundos e Transferências (SGFT) – Dispõe acerca da utilização de recursos do Cofinanciamento Federal no atendimento às demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social

Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (Loas)

Resolução 313, de 19 de março de 2020 – Conselho Nacional de Justiça

Resolução Cnas 33, de 12 de dezembro de 2012 – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (Nob Suas)

Resolução 109, de 11 de novembro de 2009 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais

2 - APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o Plano de Contingência da Assistência Social para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social ante a pandemia do COVID-19. O Plano de Contingência é um instrumento de planejamento como alternativa para organização e reorganização da oferta dos serviços socioassistenciais considerando as instabilidades apresentadas durante o período de pandemia do COVID-19, de forma que afete o menos possível o funcionamento normal dos serviços públicos.

O Plano de Contingenciamento faz-se necessário e justificável pela necessidade da manutenção de programas, projetos, serviços e benefícios no âmbito da Assistência Social, os quais são compreendidos enquanto essenciais à população, minimizando impactos. Todavia, consideram-se as medidas de proteção necessárias para que demandatárias/os e profissionais estejam resguardados e evitem o avanço da contaminação.

Algumas medidas como a organização de escala das/os funcionárias/os e o atendimento remoto são adotadas como forma de continuidade dos serviços e garantia de atendimento. Para tanto, são disponibilizados contatos telefônico e watts app de cada um dos setores/equipamentos (conforme ANEXO 1), a fim de viabilizar o contato com o público sem a necessidade recorrente de atendimento presencial. Além disso, outras metodologias são adotas pelas equipes á medida que percebe-se a necessidade de contato, prezando sempre pela ética e pelo comprimento das normativas da Política de Assistência Social.

O plano será executado enquanto o quadro de pandemia/adversidade estiver instalado e reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, sendo avaliado e readequado com frequência, além de ser desenvolvido de maneira integrada e permanente por todos os atores envolvidos.

Para tanto, considera-se, além do contexto mundial provocado pela pandemia, as reais necessidades e possibilidade da Política de Assistência Social no Município.

3 - OBJETIVOS

3.1 - Objetivo Geral

Assegurar a proteção social das famílias e indivíduos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, contaminadas ou não, no município de São Desidério, dadas as condições de emergência e calamidade pública, de forma a reduzir os impactos gerados.

3.2 - Objetivos Específicos

• Definir ações emergenciais de gestão e ofertas da Assistência Social diante da pandemia;
• Garantir a cobertura de serviços, programas e projetos socioassistenciais;
• Aliviar as consequências da pandemia para as populações mais vulneráveis;
• Contribuir para a concretização da medida de isolamento junto às famílias e indivíduos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social;
• Intensificar a proteção social famílias e indivíduos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, contaminadas ou não;
• Garantir sobrevivência da população mais vulnerável, impedida de desenvolver suas atividades laborais, estando contaminadas ou não;
• Garantir a supervisão, o apoio técnico integrado e a participação do controle social na implementação do Plano, visando à efetividade e à sustentabilidade das ações.

4 - PÚBLICO ALVO

População em situação de vulnerabilidade e/ou risco social;
População pobre e extremamente pobre;
Idosos (as) e outros grupos de risco integrantes de famílias pobres e extremamente pobres que sofreram ou não o contágio pelo COVID – 19.

5 - GESTÃO DO SUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Municipal de Assistência Social de São Desidério, responsável pela Gestão do SUAS, mantém o horário de funcionamento: das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, prioritariamente com o serviço interno através da escala de servidores, mantendo-se como ponto de referência para o atendimento ao público para informações e encaminhamento das demandas aos respectivos equipamentos e setores que compõem a rede socioassistencial, garantindo a segurança de demandatários, servidoras/es e a continuidade dos trabalhos com vistas à garantia de direitos.
Faz-se necessário ressaltar que, ainda que para a realização de trabalho interno as/os profissionais deverão obedecer às orientações e determinações previstas nos Decretos Municipais e/ou Estaduais, no que tange ao uso de EPI, distanciamento social e demais medidas preventivas. Bem como orientar quanto ao cumprimento das normas previstas ao público atendido, como a higienização para acesso ao interior do equipamento, quando da necessidade de atendimento, dentre outras previsões legais.
Os CRAS e CREAS continuam abertos, com rotinas diferenciadas de atendimento, inclusive com agendamento para preservar a saúde tanto da Equipe Técnica como dos (as) usuários (as), como determina a Portaria 337\2020. Sendo assim a gestão estabelece uma divisão de tarefas entre as equipe do SUAS de acordo com os níveis de proteção a fim de garantir acompanhamento psicossocial para o público prioritário dos serviços socioassistenciais, assim como para os demais atingidos pela situação de emergência ou calamidade que passaram a ser público da Assistência Social.
Complementando as ações da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, é importante destacar o acompanhamento dos indivíduos e famílias que necessitam de isolamento social em decorrência da pandemia. Esta é uma ação exclusiva do SUAS, sendo assim buscamos garantir, independentemente da amplitude do ocorrido, o apoio e acompanhamento integral as famílias e indivíduos, garantindo as seguranças afiançadas pela Política de Assistência Social
Em quaisquer dos setores e/ou equipamentos, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

- Usar máscara de forma permanente e demais equipamentos de segurança;
- Lavar as mãos com água e sabão periodicamente;
- Usar álcool em Gel sempre que necessário;
- Manter pelo menos 1,5m de distância de outras pessoas.
- Manter os espaços e matérias de trabalho higienizados.

Além das medidas de proteção e prevenção que ficam orientadas para todos os servidores, destacam-se as competência da Gestão da Política Municipal de Assistência Social para adequação dos serviços, programas, projetos e benefícios:

6.1 - Ações específicas no âmbito da GESTÃO DO SUAS

- Adequação na oferta dos serviços socioassistenciais com vistas à garantia de direitos das/os demandatárias/os e preservação da saúde das/os profissionais, adotando regime de trabalho remoto e escala de trabalho, a fim de evitar aglomeração nos setores e contato excessivo com o público;
- Divulgação de comunicado oficial para a população referente à redução da oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais que geram aglomerações, utilizando redes sociais, blogs, rádio e carro de som para divulgação;
- Revisão do planejamento orçamentário e financeiro com a perspectiva de considerar investimentos e ampliação da concessão de benefícios eventuais;
- Suspensão dos trabalhos em grupo (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, grupos do PAIF e PAEFI) e de visitas domiciliares, com exceção das famílias em situação de vulnerabilidade com membros contaminados pelo COVID-19 e situações emergenciais identificadas pelas Equipes de Referência;
- Elaboração de estratégias para comunicação com os (as) usuários (as), pautando meios digitais a serem utilizados, em parceria com a Assessoria de Comunicação do município, com informativo periódico sobre a oferta de serviços e demais medidas de prevenção e proteção durante a pandemia;
- Realização de campanhas de mobilização e conscientização através de cards e vídeos para as redes sociais, spots de rádio e etc;
- Manutenção de Campanhas temáticas voltadas ao Público da Política de Assistência Social: Combate à Violência contra a Mulher, Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, Combate à LGTBFobia, Combate ao Trabalho Infantil, dentre outras.
- Referenciamento da Secretaria de Assistência Social como ponto de atendimento e orientação referente ao Cadastro Único, Programa Bolsa Família e os serviços socioassistenciais, como forma de manter o referenciamento da Política de Assistência Social;
- Disponibilizar um (a) único (a) profissional que não esteja dentro do perfil de classificação de risco para estabelecer contato com a população esclarecendo dúvidas sobre o acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, Cadastro Único e programas de transferência de renda;
- Disponibilização de materiais de higiene e Equipamentos de Proteção Individual - EPI, para profissionais do SUAS que estarão no contato direto com a população;
- Disponibilização dos contatos telefônicos e e-mails de cada um dos equipamentos para garantia da fluidez no trabalho remoto;
- Aquisição de equipamento eletrônicos necessários para a garantia de atendimento remoto qualificado;
- Garantia de medidas de proteção e prevenção ao COVID-19 para as/os profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), instituindo regime de escala para atividades presenciais e modo de trabalho remoto (home office e vídeo conferência);
- Realização de reuniões por meio de plataformas digitais com as coordenações e equipes de referência para manter a organização do processo de trabalho;
- Orientação às equipes de referência, através da área de Gestão do Trabalho e Educação Permanente sobre questões pertinentes ao fazer profissional, como: capacitação virtual através de vídeos para os (as) trabalhadores (as) do SUAS sobre

o tema, bem como a definição de metodologia para garantir a fluidez do trabalho remoto/home office.

- Distribuição e EPIs para funcionários dos diferentes setores e equipamentos;
- Distribuição de Máscaras de proteção em locais de grande circulação de pessoas (principalmente agências bancárias), com orientações sobre o uso correto de EPI e a importância do distanciamento social, em parceria com a Vigilância sanitária;
- Envio de ofício ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) sobre as alterações na oferta dos serviços socioassistenciais, para que o cofinanciamento não seja alterado;

6.2 - Algumas ações são inerentes à área de Vigilância Socioassistencial, a saber:

- Registro em instrumento de planejamento e monitoramento da oferta diferenciada dos serviços socioassistenciais, no sentido de alimentar os sistemas federais e estaduais;
- Elaboração de mapeamento das situações de vulnerabilidade, risco social e violações de direitos identificadas no município por meio do diagnóstico elaborado pelas equipes da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial;
- Buscar, através dos prontuários e relatórios quantitativos das famílias atendidas pelo SUAS, informações que possam facilitar a identificação das situações de contaminação e realizar o cruzamento dessas informações com os dados de outras políticas públicas, principalmente com a Saúde.
- Articulação e monitoramento de casos junto com à Vigilância Sanitária/ do, com criação de um fluxo de encaminhamentos da Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária para a Secretaria Municipal de Assistência Social das demandas eminentes dos casos de contaminação da COVID-19, sobretudo em elação à concessão de Benefícios Eventuais;

7 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS:

Os benefícios eventuais serão concedidos, em caráter provisório, como prazos distintos, a depender da situação decorrente, sendo feita através da oferta de bens de consumo, em conformidade com as demandas dos requerentes e a realidade local, considerando as disposições da lei Municipal 06/2009 e demais normativas Estaduais e Federais que versam sobre a concessão de benefícios eventuais.
Os benefícios pecuniários (recurso), também em caráter provisório, deve estar de acordo com o grau de vulnerabilidade. Em se tratando da regulamentação Municipal, adequa-se à Lei 02/2011 que institui o Programa Municipal de Renda Mínima Cidadã.
Ressalta-se que a oferta dos benefícios deve estar alinhada aos serviços socioassistenciais.

7.1 - Ações específicas no âmbito dos Benefícios Eventuais:

- Ampliar a concessão de Benefícios Eventuais.
- Viabilizar a concessão de Benefícios Eventuais alimentação para a população atingida economicamente pela pandemia;

- Incluir no programa Municipal Prato Cheio os casos que precisem de Cestas Básicas por um período superior a três meses, os quais atendam aos critérios previstos na lei Municipal 016/2007;
- Proceder com os encaminhamentos necessários para subsidiar custos com os possíveis sepultamentos (auxílio funeral);
- As Equipe de Referência do CRAS e/ ou CREAS encaminharão as famílias para serem inseridas em programas de transferência de renda e benefícios adicionais, quando necessário. No caso dos programas Municipais como Prato Cheio (Cesta Básica) e Renda Mínima, estes devem ser previamente cadastrados e viabilizadas documentações necessárias para que, encaminhadas ao Setor de benefícios da SAS sejam inclusas nos respectivos programas.

8 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA

O setor do Cadastro Único e Bolsa Família passa a realizar atendimentos ao público prioritariamente pela modalidade de trabalho remoto, através de telefone e watts app, conforme prevê a Portaria 368/2020, priorizando atendimentos relacionados ao cadastro de famílias e indivíduos no Cadastro Único e Programa Bolsa Família para acesso aos programas sociais e de proteção social.
O horário de funcionamento será das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda à sexta-feira, seja na modalidade remota, através do telefone ou watts app, ou presencial (por agendamento), com a organização dos horários e dias de trabalho das/os profissionais por escala, considerando as demandas e adequações do serviço.

8.1 - Ações Específicas no Setor do Cadastro Único e Programa Bolsa Família

- Serão priorizados atendimentos que referem-se à bloqueio e desbloqueio de cartão do Programa Bolsa Família, bem como atendimentos que visem o acesso à Programas e benefícios, como o Auxílio Emergencial do Governo Federal, Programa Municipal Renda Mínima Cidadã, dentre outros.
- Ficam suspensos os atendimentos (presenciais e remotos) para atualização de cadastros, considerando a não obrigatoriedade de atualização cadastral para o Programa Bolsa família e para o Benefício de Prestação continuada (BPC) em decorrência da Pandemia;
- Os caso que necessitam de atendimento presencial serão agendados previamente, de modo a evitar aglomerações.

A fim de que as informações possam chegar ao Público de modo objetivo e acessível, a gestão do Cadúnico e Bolsa Família buscará a elaboração e publicação de comunicados para a população referente às orientações do Governo Federal, através das redes sociais, mídias oficias do município e fixação de cartazes em locais estratégicos do município.

9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A oferta do Serviço de proteção e Atendimento Integral à Família, principal serviço executado por meio do Centro de Referência de Assistência Social fica mantido por meio do trabalho remoto, atendimentos presenciais e visitas domiciliares em casos excepcionais, no horário de expediente das 8h às 12h e das 14h às 17h com escala de

funcionários, de modo a garantir a cobertura de todos os dias e horários com Equipe de Referência, tanto na Sede do CRAS, no Bairro Tangará, quando no Centro de Convivência (anexo) no Bairro Alto do Cristo.

9.1 - Ações específicas no âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às famílias – PAIF:

- Viabilizar a manutenção do funcionamento do CRAS, sendo suspensas as atividades de grupo/coletivas e/ou busca ativa, bem como visitas domiciliares, podendo ser realizadas nos casos em que a (s) equipe (s) avaliem como necessárias.
- Os atendimentos e acompanhamentos às famílias inseridas no PAIF serão realizados pela Equipe de Referência (Técnico de plantão), prioritariamente por meio remoto (telefone e watts app), através dos números: XXXXX;
- Os atendimentos esporádicos, os quais não se tratam de famílias acompanhadas poderão ser realizados por Técnicos de Referência bem como por demais servidores do CRAS, a depender do caráter da demanda, preferencialmente por meio remoto e presencialmente, quando necessário, sobretudo para demandas emergenciais ante a situação de pandemia, como as orientações para acesso a benefícios e auxílios emergências;
- Os atendimentos presenciais, quando necessários, serão realizados por meio de agendamento prévio, resguardadas todas as medidas e orientações de prevenção das/os servidoras/es e demandatárias/os.
- As visitas domiciliares serão realizadas em casos excepcionais, preferencialmente com em área externa ao domicílio e com um/a técnica de referência, a fim de evitar aglomeração e contato desnecessário.
- O cadastro para avaliação de concessão de benefício Eventual poderá ser feito por meio remoto, dispensados atendimentos presenciais e visitas domiciliares, quando o atendimento remoto for considerado suficiente para análise da demanda;
- A entrega do benefício eventual será realizada no domicílio, observadas todas as orientações concernentes à visita domiciliar;
- Distribuir máscaras nas filas dos bancos e nas casas de famílias referenciadas, atendendo primeiro as famílias com pessoas em grupo de risco (hipertensos, idosos, gestantes, lactantes, diabéticos, com doenças crônicas, e pessoas com deficiência).

9.2 - Ações específicas no âmbito do BPC/BPC na Escola:

Considerando que as atividades relacionadas ao BPC e BPC na Escola acontecem em consonância com as atividades do PAIF/CRAS, seguem

Monitoramentos das famílias do BPC e BPC na Escola que estão em acompanhamento familiar;

Levantamento de casos que necessitam de continuidade de continuidade de acompanhamento;

Comunicação às famílias com processo de BPC no INSS sobre liberação de auxílio;

Orientar e informar as pessoas com deficiência em meio aos cuidados que devem ser tomados durante a pandemia e o cuidado que devem ter os que trabalham como cuidadores, atendentes pessoais;

Divulgação do informativo do Governo Federal para pessoas com deficiência contra o novo coronavírus - linguagem acessível, orientações de prevenção para pessoas com

doenças raras e diferentes tipos de deficiência – física, visual, auditiva, intelectual e surdocegueira;
Orientações as novas regras do BPC e o acesso ao INSS digital

10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

No Município de São Desidério a Proteção Social Especial aos indivíduos e famílias em situação de violação de Direitos será ofertado através dos seguintes níveis de proteção e respectivos equipamentos:
- Média Complexidade: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, com funcionamento de segunda á sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, organizado através de escalas, de modo a garantir que em todos os dias e horários haja a presença de Técnica de Referência no equipamento para atendimento (presencial ou remoto) das respectivas demandas;
- Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento ao Idoso, por meio da ILPI – Instituição de Longa Permanência do Idoso, com funcionamento ininterrupto, com escalas e plantões, com garantia de equipe suficiente para a demanda do equipamento.

10.1 - Ações específicas no âmbito da Média Complexidade - CREAS:

- Viabilizar a manutenção do funcionamento dos CREAS, sendo suspensas as atividades de grupo/coletivas e abordagem social e/ou busca ativa, bem como visitas domiciliares, podendo ser realizadas nos casos em que a (s) equipe (s) avaliem como necessárias.
- Estabelecer fluxos entre CRAS e CREAS para atendimento às famílias e indivíduos;
- Assegurar a permanência ininterrupta de técnico de referência (alternando assistente social, psicóloga e advogada) para atendimento às famílias e indivíduos que vivenciam situações de emergência e calamidade pública, passam por circunstâncias de risco pessoal ou social em decorrência das violências e/ou violações de direitos geradas por essas situações;
- Os atendimentos serão realizados preferencialmente, por meio remoto e, sempre que necessário, agendados atendimento presenciais na sede do CREAS;
- As visitas domiciliares serão realizadas em casos excepcionais, preferencialmente com agendamento prévio, em área externa ao domicílio, se possível com apenas uma das técnicas da equipe, evitando assim aglomeração e resguardando a segurança das/os demandatárias/os;
- Poderá ser realizado atendimento via vídeo conferência, excepcionalmente, seguindo as recomendações do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS);

10.2 Ações específicas no âmbito da Alta Complexidade - ILPI:

- Garantir a manutenção da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI);
- Manter a organização da Equipe com escalas e plantões de modo a garantir a cobertura em todos os dias e horários, com adequação de carga horária e acréscimo de hora-extra, quando necessário, a fim de evitar o acréscimo de mais profissionais à equipe, considerando o contato direto com os idosos acolhidos;

- Realizar atividades contínuas de orientação acerca das medidas de prevenção do COVID-, como lavar as mãos adequadamente e conscientização com o afastamento social com todos funcionários;
- Atender demandas de novos casos de acolhimento, quando necessário, observadas todas as recomendações das instituições sanitárias, seja para a situação de visita domiciliar, seja para um possível acolhimento da pessoas idosa na instituição;
- Suspender as visitas no centro de acolhimento das/os idosas/os (inclusive de familiares, salvo raras exceções)
- Suspender atividades externas habitualmente realizadas com as/os idosas/os acolhidas/os (visitas aos familiares, passeios, etc);
- Manter as/os familiares informados sobre o processo de acolhimentos da/os usuárias/os;
- Adotar medidas restritas na portaria, com monitoramento e justificativa para as saídas de funcionárias/os;
- Adotar os protocolos de higiene dos profissionais, dos equipamentos, itens e dos ambientes.
- Disponibilizar máscaras para as/os idosas/os e manter o uso de itens individuais, como copo, talheres e outros;
- Manter a realização de atividades ocupacionais, lúdicas, cognitivas e psicomotoras, observadas as orientações de distanciamento social e evitar a aglomeração;
- Transferir, em caso de suspeita ou confirmação de contaminação, o (a) acolhido (a) para quarto separado, sendo realizada a devida articulação e informação a unidade de saúde para atendimento e isolamento adequado;
- Criar estratégias em casos de encaminhamentos para novos acolhimentos, para que esta ação aconteça em espaços distintos e separados dos acolhidos já inseridos na unidade ou em outras unidades de acolhimento criadas especificamente para este fim.

11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

12 – ANEXOS

12.1 – ANEXO I – Contatos telefônicos, watts app e e-mail para atendimento ao público

Secretaria Municipal de Assistência Social
(73) 998456096
assistenciasocial@saodesiderio.ba.gov.br
Cadastro Único e Bolsa Família
(77) 999203681 / (77) 999225761
bolsafamilia@saodesiderio.ba.gov.br
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
(77) 999987497
cras@saodesiderio.ba.gov.br
CREAS – Centre de Referência Especializado de Assistência Social
(77) 998445510
creas@saodesiderio.ba.gov.br
ILPI – Instituição de Longa Permanência de Idosos
(77) 991950008
cci@saodesiderio.ba.gov.br